

## 総論

## 抗がん剤の分類と作用機序:薬剤師の実践ポイント

服薬指導・相互作用・病院との連携のポイント

## 1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

## 保険薬局薬剤師

- ☐ 経口抗がん剤の服用時点・服用日・残薬の管理
- ☐ 他院処方・市販薬・サプリを含む相互作用の確認
- ☐ 服用期間中の電話フォローと早期受診の勧奨
- ☐ 副作用をGradeで記録し、トレーシングレポートで病院へ
- ☐ 家庭での曝露対策・長期服用のアドヒアランス支援

## 病院薬剤師

- ☐ レジメン監査・投与量計算・前投薬の確認
- ☐ 抗がん剤の調製と曝露対策
- ☐ 外来化学療法室での副作用説明・導入時の指導
- ☐ 副作用発現時の院内連携(各診療科)
- ☐ お薬手帳へのレジメン情報の記載・薬局への情報提供

## 病院と共有する情報

レジメン名・投与日

検査値

副作用のGrade

服用状況・残薬

## 2 経口抗がん剤の服用時点と注意点

| 薬剤      | 服用時点・食事の影響                    | 主な注意点                                       |
|---------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| S-1     | 1日2回 朝夕食後                     | 4週服用・2週休薬などの休薬期間、腎機能に応じた用量、他のフッ化ピリミジン系と併用禁忌 |
| カペシタビン  | 1日2回 朝夕食後30分以内                | 手足症候群、ワルファリン併用時のINR上昇                       |
| エルロチニブ  | 1日1回 空腹時(食事の1時間以上前または食後2時間以降) | 皮疹・下痢、胃酸分泌抑制薬で吸収低下、喫煙で血中濃度低下                |
| ニロチニブ   | 1日2回 空腹時(同上)、約12時間ごと          | QT延長、グレープフルーツ、胃酸分泌抑制薬                       |
| アビラテロン  | 1日1回 空腹時(食事の1時間前～食後2時間は避ける)   | プレドニゾロンの併用、肝機能・低K血症・高血圧                     |
| レゴラフェニブ | 1日1回 食後(高脂肪食の後は避ける)           | 手足症候群、投与初期の肝機能・血圧                           |
| タモキシフェン | 1日1回                          | CYP2D6阻害薬(パロキセチン等)、血栓症・子宮体がん                |

## 3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

| 重要度                       | 薬剤(機序)                         | 相手の薬(区分)                         | 起こること                | 薬局での対応              |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>禁忌</b><br>添付文書<br>併用禁忌 | S-1<br>DPD阻害(ギメラシル)            | 処方薬<br>他のフッ化ピリミジン系(カペシタビン・5-FU等) | 5-FU濃度↑ → 重篤な骨髄抑制・下痢 | 切り替え時は7日以上空ける       |
| <b>注意</b><br>添付文書<br>警告   | カペシタビン<br>CYP2C9の抑制            | 処方薬<br>ワルファリン                    | INR↑ → 出血            | INR測定を頻度を処方医と確認     |
| <b>注意</b><br>添付文書<br>併用注意 | 経口分子標的薬(イマチニブ等)<br>CYP3A4阻害・誘導 | 処方薬<br>クラリスロマイシン・アゾール系・リファンピシン   | 副作用↑・効果↓             | 他院の抗菌薬・抗真菌薬・抗結核薬を確認 |
| <b>注意</b><br>添付文書<br>併用注意 | エルロチニブ・ダサチニブ等<br>胃内pH上昇で吸収低下   | 処方薬 市販薬<br>PPI・H2ブロッカー(市販の胃薬も)   | 血中濃度↓ → 効果減弱         | 市販の胃薬も確認、服用時間を調整    |
| <b>注意</b><br>添付文書<br>併用注意 | 経口分子標的薬<br>CYP3A4阻害・誘導         | サプリ・食品<br>グレープフルーツ・セイヨウオトギリソウ    | 副作用↑・効果↓             | 食品・サプリの摂取を聴取        |
| <b>注意</b><br>添付文書<br>併用注意 | タモキシフェン<br>CYP2D6阻害(活性化↓)      | 処方薬<br>パロキセチン等のSSRI              | 効果減弱のおそれ             | 他院の抗うつ薬の処方を確認       |

## 4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

## 治療開始前

「がん細胞の増殖のスイッチを止める薬です。毎日決まった時間に飲み続けることが大切です」

確認:お薬手帳でレジメン・分類、他院処方・市販薬・サプリ

△ 経口薬は粉砕・脱カプセルしない(曝露対策)

## 開始～2週

「熱や下痢、皮膚の変化など、今までと違う症状があれば、次の受診を待たずに教えてください」

確認:電話フォローで分類ごとの初期症状(発熱・皮疹・下痢)を確認

△ 発熱・水様便が続く時は至急連絡

## 1～3か月

「だるさや口の渇き、動悸が続く時も連絡を。免疫の薬は時間がたってから症状が出る場合があります」

確認:ICIのirAE、家庭血圧・尿蛋白(血管新生阻害薬)

△ 息切れ・空咳・発熱はILDを疑い早めに受診

## 長期服用中

「関節の痛みやほてりは対処法があります。自己判断でやめずに相談してください」

確認:ホルモン剤・分子標的薬の継続状況と残薬、骨密度検査

△ 自己中断・飲み忘れはトレーシングレポートで共有